

PROTOCOLO GASTROENTERITIS AGUDA

Unidad de observación de media estancia (UOME)

1. OBJETIVO

El objetivo principal es el manejo protocolizado de pacientes diagnosticados en Urgencias de gastroenteritis aguda con o sin alteraciones hidroelectrolíticas asociadas hasta conseguir su rehidratación y estabilización clínica y recuperando la tolerancia oral en un plazo de 24-36 horas.

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Pacientes estables con gastroenteritis aguda (diarrea $\pm$ vómitos) con **deshidratación leve–moderada** que puedan a su vez asociar o no otras alteraciones subsidiarias de mejora en el plazo establecido (lesión renal aguda prerrenal o alteraciones hidroelectrolíticas) o que mantengan intolerancia oral a pesar de administración de antieméticos.

LEVE	MODERADA	GRAVE
Sed	Mucha sed	Taqui/bradicardia
Orina concentrada	Oliguria	Hipoperfusión
	Mucosas secas y ojos hundidos	Hipotensión marcada
	Debilidad y mareo	Confusión
	Hipotensión ortostática	Letargo

Condiciones mínimas:

- **Estabilidad hemodinámica** sin criterios de shock
- Sin datos de patología quirúrgica abdominal
- **Lesión renal aguda de perfil prerrenal** sin criterios de hemodiálisis urgente
- **Alteraciones hidroelectrolíticas**
 - Hiperpotasemia leve o moderada

CAMBIOS ECG

NIVELES DE POTASIO

	5.0-5.9	6.0-6.4	>6.4
--	---------	---------	------

PRESENTES	Moderado	Grave	Grave
AUSENTES	Leve	Moderado	Grave

- Hipopotasemia sin alteraciones electrocardiográficas (Onda U prominente o fusión con onda T, Onda T aplanada o invertida y/o depresión del segmento ST)
 - Sodio < 160mEq/L
 - pH > 7 o pH<7.60
-

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Pacientes sugestivos de valoración por UCI:

- **Shock/hipoperfusión** o necesidad de reanimación continuada

Pacientes sugestivos de valoración por CIRUGÍA GENERAL/RADIOLOGÍA:

- Sospecha de **abdomen quirúrgico** (defensa, dolor focal progresivo, obstrucción...)

Pacientes con antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal y sospecha de brote

Pacientes sugestivos de ingreso en MEDICINA INTERNA o secciones

- **Alteraciones hidroelectrolíticas graves** o deshidratación grave
- **Cetoacidosis diabética o estado hiperglucémico hiperosmolar**
- **Comorbilidad relevante** que incremente riesgo/complicación (anciano frágil con dificultad para rehidratación oral, inmunosupresión grave o neutropenia...)
- **Problema social** que impida correcta hidratación o seguimiento

Valoración por GINECOLOGÍA siempre en gestantes con gastroenteritis febril

4. EVALUACIÓN INICIAL

4.1 Clínica y monitorización basal

- Constantes, perfusión periférica, estado mental.
- Estimación de deshidratación y control de diuresis

4.2 Analítica

- **Bioquímica**

- Función renal e iones (añadir magnesio si hipopotasemia)
- Proteína C Reactiva
- Valorar procalcitonina en función clínica y analítica
- **Hemograma**
- **Gasometría venosa**
- **Electrocardiograma si alteraciones hidroelectrolíticas**

4.3 Microbiología

- **Hemocultivos:** solo si fiebre alta con sospecha de sepsis o inmunodeprimido
- **Coprocultivo:** en todos los pacientes que ingresen en Unidad de Observación
- **Toxina *C. Difficile*:** Si antibioterapia u hospitalización en 3 meses previos, paciente institucionalizado, > 65 años o toma crónica de IBPs.
- **Estudio de parásitos en heces:** si diarrea persistente, antecedentes de viaje reciente a país endémico u otras asociaciones epidemiológicas (inmigrantes e inmunodeprimidos).
- **Muestra rectal para *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis* y herpes simple:** Indicado en diarrea con dolor rectal, secreción o exposición sexual

5. TRATAMIENTO EN UOME

1.1 Rehidratación: Iniciar rehidratación intravenosa con suero salino fisiológico al 0.9% hasta normalizar pulso y perfusión. Posteriormente pasar a suero de rehidratación oral hipoosmolar si buena tolerancia oral. Asegurar que las entradas de fluidos sean mayores que las pérdidas.

1.2 Antieméticos:

- Metoclopramida: Evitar en pacientes con antecedentes de discinesia tardía inducida por neurolepticos, epilepsia, enfermedad de Parkinson, combinación con levodopa o agonistas dopaminérgicos. Administrar con precaución en pacientes que tomen neurolepticos o serotoninérgicos
- Ondansetrón: De elección en paciente oncológico
- Metilprednisolona/dexametasona
- Benzodiazepinas si sospecha de síndrome de hiperémesis cannabinoide

1.3 Analgésicos/antitérmicos: Uso según necesidad clínica y tolerancia

1.4 Dieta basal si tolerancia oral adecuada

1.5 Antibioterapia: considerarlo si cumple al menos uno de los siguientes criterios

- ✓ Disentería (fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$, $>50\%$ mucosidad en heces o diarrea sanguinolenta), dolor abdominal intenso o deshidratación moderada-grave
- ✓ Cuadro > 7 días de evolución
- ✓ Diarrea moderada-grave en pacientes con enfermedad sistémica subyacente grave, prótesis intravasculares o bien inmunocomprometidos (trasplantados, tratamiento corticoesteroideo, neoplasias, diabéticos mal controlados) o anciano frágil
- ✓ Drepanocitosis
- ✓ Diarrea del viajero moderada/grave

6. ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA

- a) En general: **Ciprofloxacino 500 mg/12h** durante 3-5 días
- b) Como alternativa a ciprofloxacino o si sospecha de *Campylobacter*: **Azitromicina 500mg/24h** durante 3 días
- c) Si primer episodio de *Clostridioides difficile* sin criterios de gravedad ni recurrencia: **Vancomicina 125 mg/6h** vía oral durante 10 días
- d) Si recurrencia de episodio de *Clostridioides difficile*, criterios de gravedad o alto riesgo de recurrencia (>65 años, historia previa de infección por CD, comorbilidades graves/descompensadas como diálisis, cirrosis hepática, diabetes avanzada y complicada, enfermedad inflamatoria intestinal activa o inmunosupresión): **Interconsulta a Medicina Interna o UCI**

Criterios de gravedad infección por CD	
Grave	Muy Grave
Leucocitos $>15000/\text{mcl}$	Hipotensión, sepsis o shock
Cr >1.5 veces el valor previo (o $>1.5 \text{ mg/dl}$ si no existen valores previos)	leucocitos >35.000 o <2.200
$T^{\text{a}} >38.5^{\circ}\text{C}$	Íleo o megacolon
Pseudomembranas	Alteración del estado mental,
	Lactato $>2.2\text{mmol/l}$ o PCT elevada

7. TRATAMIENTO ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS

HIPERPOTASEMIA:

- 1) Suspender si es posible fármacos hiperkalemiantes (Inhibidores del sistema renina angiotensina. Antiinflamatorios no esteroideos. Betabloqueantes. Trimetoprima. Pentamidina. Suplementos de K. Heparina. Inhibidores de la calcineurina)

- 2) Si alteraciones electrocardiográficas: Gluconato cálcico 10% 10-30 mL intravenoso a pasar en 5 minutos. Se puede repetir dosis si 5 minutos tras la finalización del tratamiento continúan las alteraciones
- 3) Insulina + glucosa: 10 UI de insulina rápida en 500 mL de glucosado al 10%
- 4) Salbutamol 10-20cc en nebulización
- 5) Furosemina: Entre 40 y 100 mg intravenoso
- 6) Valorar ciclosilicato de sodio y zirconio

HIPOPOTASEMIA:

- 1) Valorar hipomagnesemia concomitante. Si hipomagnesemia, restaurar antes el Mg.
- 2) Por vía periférica se puede reponer un máximo de 40mEq/L y a una velocidad máxima de 10mEq/h.
- 3) Si acidosis concomitante, reponer primero el potasio.

HIPERNATREMIA: (asumiendo hipernatremia hipovolémica)

- 1) Calcular déficit de agua libre. Administrar el 50% del déficit en las primeras 24 horas. El resto en las siguientes 24/48h. Iniciar con solución salina isotónica al

$$DAL = 0,6 \times \text{Peso (kg)} \times \frac{[Na]p - 140}{140}$$

0,9%

HIPOMAGNESEMIA: tratar si hipopotasemia asociada o magnesio <1.2mg/dL

- 1) Bolo de 1-1,5 ampollas de sulfato magnésico [12-18 mEq] en 5-10 minutos
- 2) Perfusión de cuatro ampollas [48 mEq] en las siguientes 6-24 horas
- 3) Pasar a aportes orales

ALCALEMIA Y ACIDEMIA METABÓLICAS: Tratamiento de la causa, en nuestro caso, hidratación.

8. MONITORIZACIÓN

- Constantes cada 4-6h
- Monitorización electrocardiográfica si alteraciones iónicas
- Diuresis y balance (sondaje si es necesario para monitorización estricta en seleccionados).
- Tolerancia oral (SRO/dieta) y número de vómitos/diarreas.
- Reevaluación clínica documentada al menos cada 8 h
- Repetición de analítica: Repetir electrolitos/función renal a **6-8 h** tras iniciar reposición intravenosa si alteración leve y **a las 2 horas** si alteración

moderada/grave.

9. DESTINO

Alta domiciliaria

- Mejoría clínica de deshidratación (mucosas, perfusión, mareo/ortostatismo, estado general).
- Tolerancia oral suficiente (SRO + dieta) sin vómitos persistentes.
- Constantes estables.
- Función renal y electrolitos: normalizados o en franca mejoría con plan domiciliario

Ingreso hospitalario

- Criterios de exclusión
- Empeoramiento clínico o signos de hipoperfusión
- Alteraciones electrolíticas relevantes o progresivas o que no consigan corrección en un plazo de 24 horas.
- Intolerancia oral persistente que impide plan ambulatorio

Derivación a Fundación Hospital de Avilés

Paciente frágil, dificultad social, necesidad de cuidados intermedios, respuesta parcial a rehidratación, pero sin criterios de ingreso agudo.

10. RECOMENDACIONES AL ALTA

Pauta de solución de rehidratación oral al alta.

Se entregará hoja de recomendaciones disponible en papel en Unidad de Observación y en este documento de forma anexa.

Valorar antibioterapia según criterios previos y coprocultivo (si hay resultados)

11. BIBLIOGRAFÍA

1. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). Clinical Practice Guidelines. Updated continuously. Basel: ESCMID; 2025.
2. Ministerio de Sanidad. Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN). Recomendaciones sobre uso prudente de antimicrobianos. Actualización 2025.
3. Nefrología de urgencias: algoritmos prácticos para el diagnóstico y tratamiento. Balmes 209, 3º 2ª 08006 Barcelona: Esmon Publicidad, S.A.; 2024.
4. Tay WL, Chien JM, Poulose V, How CH, Ng MCW. Acute gastroenteritis in adults. Singapore Med J. 2025;66(8):457-461. doi:10.4103/SMJ.SMJ-2022-161
5. Meisenheimer ES, Carly Epstein DO, Mph DTM. Acute Diarrhea in Adults. American Family Physician. 2022;106(1):72-80.

RECOMENDACIONES AL ALTA PARA PACIENTES CON GASTROENTERITIS AGUDA

¿Qué es la gastroenteritis aguda?

La gastroenteritis aguda es una enfermedad caracterizada por la aparición de diarrea (con o sin vómitos), generalmente causada por una infección intestinal. Puede acompañarse de dolor abdominal intermitente y/o fiebre. En la mayoría de los casos está producida por virus y se resuelve espontáneamente en pocos días, sin necesidad de tratamiento antibiótico. El objetivo principal del tratamiento es prevenir la deshidratación y aliviar los síntomas.

¿Qué debo hacer en casa?

Rehidratación oral: Utilice el suero oral pautado en pequeñas cantidades (sorbos o cucharaditas) de manera continuada y especialmente tras cada deposición o vómito. Aproximadamente deberá beber medio vaso de suero por cada deposición/vómito.

Dieta: No es necesario el ayuno. Se podrá reiniciar dieta habitual con el inicio de la tolerancia oral. No es necesario seguir dieta blanda, pero sí evitar comidas excesivamente grasas o muy azucaradas. Evite también las comidas picantes.

Medidas para evitar el contagio: Lávese las manos con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes de preparar alimentos. No comparta toallas, cubiertos o utensilios mientras tenga síntomas. Evite manipular alimentos para otras personas si es posible hasta al menos 48 horas después de que hayan desaparecido la diarrea y los vómitos. Si no es posible, extreme las medidas de higiene.

Medicación: No tome antibióticos ni otros tratamientos que no le haya recomendado un médico. Podrá seguir tomando su tratamiento habitual (salvo modificaciones comentadas expresamente durante su atención)

Acuda de nuevo a Urgencias o solicite valoración médica urgente si presenta:

- Incapacidad para hidratarse por vómitos persistentes o diarrea intensa.
- Signos de deshidratación: sed intensa, boca muy seca, disminución importante de la cantidad de orina, mareo intenso o desmayo.
- Sangre en las heces o heces negras.
- Dolor abdominal intenso, localizado o que empeora progresivamente.
- Fiebre alta persistente o deterioro importante del estado general.
- Confusión, somnolencia excesiva o dificultad para despertarse.

Evolución esperada

La mayoría de las gastroenteritis agudas mejoran en pocos días con hidratación adecuada y tratamiento sintomático. La diarrea puede persistir algunos días más, aunque con intensidad progresivamente menor. Si tiene dudas sobre la evolución o aparecen nuevos síntomas, consulte con su médico de Atención Primaria o acuda nuevamente a Urgencias.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON:

DOLOR ABDOMINAL/SUBOCCLUSIÓN/ GEA/ DESHIDRATACIÓN

En un paciente con dolor abdominal en una unidad de observación se debe vigilar los signos y síntomas de posibles complicaciones.

Signos y síntomas a vigilar y registrar

· Estado general:

- Fatiga
- Ansiedad
- Alteración del nivel de conciencia en casos graves.

· Dolor:

- Localización, intensidad, irradiación
- Inicio, duración, patrón (cólico, continuo...)
- Respuesta a la analgesia.

· Síntomas asociados:

- Presencia de náuseas y vómitos. Aspecto del vómito
- Deposiciones. Número y características.
- Fiebre
- Alteraciones del tránsito
- Signos de irritación peritoneal(defensa abdominal, Blumberg)

Registros Específicos en la Historia Clínica

· Sueroterapia y balance hídrico:

- Vigilancia de diuresis

Signos de alarma

Avisar de inmediato si aparecen:

- Dolor intenso no controlado
- Signos de peritonismo (defensa, rebote)
- Inestabilidad hemodinámica (Hipotensión, taquicardia)
- Alteraciones analíticas (leucocitosis, acidosis)

Datos de sepsis:

- fiebre persistente,
- taquicardia,
- hipotensión,
- alteración mental.

BIBLIOGRAFÍA:

1. - Ferrer Tarrés JM, Prat Marín A, Tomás Vecina S. Revisión de la utilización de las áreas de observación de urgencias hospitalarias. Med Clin (Barc). 2007;128(6):224-31. Quirónsalud.
2. - Inhaladores de cartucho presurizado: técnica de inhalación. Escuela de Pacientes Neumología. Madrid: Quirónsalud; 2023. Disponible en: <https://www.quironsalud.com> [Acceso 04 sept 2026]. Servicio Andaluz de Salud.
3. - Guía de diseño y organización de servicios de urgencias hospitalarias. Sevilla: Consejería de Salud; 2016. Soler Gómez Y, Fernández Viñado DM, Martínez Fernández C, et al.
4. - Atención de enfermería al paciente politraumatizado por accidente de tráfico: enfoque integral en la emergencia. Rev Sanitaria Invest. 2025;6(7):e2660-7085. Sánchez Reyes E, Pinal Moreno E, Ortega Vargas MC.

5. - Guía clínica de enfermería del enfermo con insuficiencia cardíaca. Rev Enferm IMSS. 2004;12(3):155-62. Grupo de Trabajo de EPOC SEMERGEN.
6. - Protocolo de manejo del paciente con EPOC agudizado en urgencias. SEMERGEN. 2020;46(Supl 1):1-12. Gómez Martínez A, González Vallejo ML, García Cuesta P.
7. - Plan de cuidados enfermeros en el paciente con EPOC y neumonía según taxonomía NANDA-NIC-NOC. Rev Enferm CyL. 2018;10(2):45-58. Gobierno de Canarias.
8. - Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos: Traumatismos II. Las Palmas: Consejería de Educación; 2021.Universidad de Salamanca.
9. - Guía docente Enfermería en Urgencia y Riesgo Vital. Grado en Enfermería. Ávila: USAL; 2024-2025.Mayo Clinic.
10. - Inhaladores para el asma: ¿cuál es el indicado para usted? Rochester: Mayo Foundation; 2024. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org> [Acceso 04 sept 2026].
11. - Guía de actuación en urgencias de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE)
12. - Cuidados de enfermería en el paciente crítico en urgencias de García González, M., et al. (2020)
13. - Manejo del paciente con dolor torácico en urgencias de López López, J., et al. (2019)
14. - Emergencias (revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias)
15. - Enfermería de Urgencias (revista especializada en cuidados de enfermería en urgencias)
16. - SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) - Guías y protocolos
17. - SEEUE (Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias) - Recursos y documentos